

Vintilă Mihăilescu, *În căutarea corpului regăsit. O ego-analiză a spitalului*, Iași, Editura Polirom, 2019, 248 p.

Eram la intersecția dintre Piața Unirii și strada Memorandumului, așteptând să se schimbe culoarea semaforului roșu. S-a întors spre mine și m-a întrebat de ce noi ardelenii așteptăm la stop. Era o după-amiază liniștită, cu traficul plictisitor al Clujului de acum vreo 10 ani. „Doar nu vine nici o mașină. De ce nu am putea să trecem pur și simplu? Ce rost are să respecti o regulă care ar trebui să te protejeze dacă nu ești deloc în pericol?” M-am fâstâcit și am bâguit un răspuns, dar cred că nici pentru mine nu suna convingător. Eram prea surprins de directetea adresării și a contextualizării problemei.

A fost singura mea interacțiune directă cu Vintilă Mihăilescu și găsesc potrivit să încep cu o rememorare personală recenzia unui volum hyper-personal, în care celebrul și mult iubitul antropolog își face o ultimă punere în ordine a vieții din fața pragului spre moarte. E un volum care m-a bulversat precum interacțiunea de la intersecție, așa că voi continua să bâgui neconvingător despre el.

Jurnal de război, crâmpie de memorii care nu au mai apucat să fie adunate mai consistent, gândurile unui erudit cum nu se mai fabrică, trimiteri bibliografice de maximă precizie și concizie, dialoguri furate de la alții, „dat din casă” (și din spital), mic compendiu despre rolul umorului în atenuarea traumelor, *În căutarea corpului regăsit* e o minunată și fascinantă călătorie introspectivă făcută publică fără rezerve. Nu pare să rămână nici un colțișor necotrobăit din propria viață care să nu fie scos la iveală. De la aventurile din nopțile târzii comuniste în care nici măcar fiolele de măsurat alcoolul nu îl luau în serios, la rememorarea figurii paterne din rolul unui pacient încătușat în spital (analizarea felului în care tatăl său înțelegea să-și practice meseria de diagnostician pare o îmbrățișare târzie adresată dincolo de timpul și încercările prin care au trecut), la amintiri intime din viața unui cuplu plin de viață, totul este scos la vedere. Pe rând se schimbă lupele prin care se privesc vechile aventuri și noile situații spitalicești de la cele folosite de antropolog, psiholog, sociolog. Uneori remarcile sunt pur și simplu cele ale unui bon-viveur care încearcă în zadar să facă glume de salon în saloanele spitalului.

„[...] a venit în vizită o tânără rezidentă și m-a întrebat cum mă simt, i-am răspuns cât se poate de serios: «Din exces de menopauză, am făcut un guturai». A înlemnit și s-a clătinat de pe picioare la propriu. A mai dat să-mi ia tensiunea, dar s-a răzgândit și a ieșit intempestiv pe ușă. De atunci n-am mai încercat niciodată să-i testez pe doctori să văd dacă au simțul umorului.” (p. 168–169).

Umorul și funcțiile acestuia par a avea o atenție aparte. În înșiruirea și analizarea mecanismelor de apărare care se declanșează o dată ce ești prins în spital (spitalul este văzut într-un sens strict foucauldian, ca un panopticon în care individului îi este ștersă personalitatea pentru a se putea ocupa „sistemul” de vindecarea sa), după ce sunt trecute sumar în revistă somnul și vorbitul, partea cea mai consistentă îi este acordată râsul și umorului care, după opinia sa, nu a fost luate suficient de în serios de către psihologi și cercetători din arii conexe. Se poate înțelege că umorul și imaginea de om nesperios a fost fundamentală pentru auto-definirea proprie, în răspăr evident cu imaginea de om foarte serios a tatălui.

„Tatăl meu a fost un om serios – mai exact, un *medic serios*! Cu vederi largi, desigur, dar serios până în măduva oaselor. Știa, desigur, să râdă, dar... cu măsură. Eu n-am avut altă soluție sănătoasă decât să-mi inventez un simț al umorului ca să contracarez și să scap de dominația seriozității paterne: a fost pur și simplu modul meu – elegant, zic eu – de a-mi ucide tatăl.” (p. 176).

Neseriozitatea în fața unei boli necrușătoare se manifestă și prin neluarea în serios a acesteia. Anunță pe toată lumea că are o boală mortală, ca pe o exorcizare a traumei, dar are parte și de un prieten psihanalist care îl ajută să atenueze prin verbalizare vestea care te ia de pe picioare. Amintește cum săptămâni la rând acest prieten îl suna doar ca să-l asculte vorbind jumătăți de oră despre tot ceea ce îi trecea prin cap. Flecăreala neserioasă are însă și un revers discret: aflăm abia după jumătatea volumului numele bolii. Teama de a o numi sau amânarea atât de îndelungată a numirii este dovada procesului îndelungat și lent de acceptare a acesteia. Vorbirea se face cu atenta ocolire a motivului pentru care spitalul ajunge să fie domesticit. Și cât de atent sunt înregistrate toate ritualurile prin care spațiile străine ale spitalului sunt, cât de cât, îmblânzite de către pacienții care sunt brusc luați pe sus de un mecanism care aduce mai degrabă cu un malaxor, decât cu un „sanatoriu”, un loc al însănătoșirii. Prima jumătate a cărții se apleacă asupra trecerii din spațiul familial în cel total nefamiliar al spitalului.

Abordarea sociologică a ce este un spital, cum funcționează el în societatea contemporană care ne înconjoară, de ce lucrurile se întâmplă așa cum se întâmplă pe partea albă a zidurilor, este o mostră de intuiție și inteligență îndelung exersate în arta surprinderii esențialului din cotidian. Concluziile sunt clare și dau notă de o înțelegere profundă a societății noastre:

„Nu, categoric nu poate fi vorba la noi de o „medicină centrată pe bolnav”. Cultura medicală nu are cum să fie atât de fundamental diferită de cultura generală în care ne-am născut și trăim cu toții. Fiind o societate predominant țărănească, am fost o cultură centrată pe comunitate; apoi, o dată cu destrămarea acestor comunități și dezvoltarea modern-urbană, am fost – și încă mai suntem – una centrată pe familie; centrarea pe individ este o atitudine relativ recentă, ce pare să se încetățenească abia o dată cu „generația Z”. ” (p. 120)

Diferențele fundamentale dintre felul în care funcționează sistemul medical românesc/balcanic și cele occidentale au la bază răspunsurile la întrebarea: este pacientul / bolnavul responsabil pentru propria însănătoșire, sau trebuie să fie vindecat? Abordarea din perspectiva bolii sau a bolnavului se dovedește a fi esențială în tot ceea ce decurge ulterior: centrarea pe boală rezumă individul la un pacient, se concentrează pe durere și eliminarea acesteia printr-o abordare paternalistă în care deciziile sunt luate exclusiv de doctorul care recunoaște și identifică boala. Dacă ar fi să avem parte de abordarea centrată pe bolnav am vedea o înțelegere holistică a unui caz, bolnavul având parte de empatie și înțelegere a suferinței sale, fiind luat în serios și în ceea ce privește capacitatea sa de a implementa acțiuni profilactice. Bolnavul este altceva decât pacientul și este evident că pacientul Mihăilescu și-ar fi dorit mult mai mult să fie tratat ca un bolnav, să aibă un cuvânt de spus în ceea ce i se întâmplă și să-i fie luate în serios informațiile relevante pentru cazul său, propria experiență.